

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	氣切傷口照護 Tracheostomy wound care				
編號	A31000-Q03-W-C09	制定者	RCC 譚靖馨	公布日期	102 年 11 月 27 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	114 年 10 月 08 日
版本/總頁數	第 2.1 版/7 頁	審查者	曾翊健	檢閱日期	114 年 10 月 08 日

一、目的

讓護理人員了解氣切傷口照護的定義、適應症、合併症、護理問題與措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

氣切手術即氣管切開手術，是以外科手術的方式，在頸部第二、三或四氣管環處切開，由切開處置放一個塑膠的氣切套管取代呼吸道，作為氣體進出的通道，以改善呼吸的功能，稱之為氣切。

（二）適應症

1. 延長使用其他人工氣道超過三週以上者，一般氣切套管比長期氣管內管插管者來得舒適。插了氣切套管之後，病人活動比較方便，而且在合適的訓練之下，病人也可以說話或吃東西。
2. 需長時期使用呼吸器協助換氣者，在特定情形下，協助病人脫離呼吸器。因為以氣管內管協助呼吸的阻力通常比氣切大，而且死腔也比較多，對於較虛弱的病人，氣管內管比氣切較不易脫離。
3. 痰液過多無法有效咳出維持呼吸道通暢者，如：上呼吸道阻塞、呼吸麻痺所造成的呼吸困難、腫瘤、水腫等。

主題名稱	氣切傷口照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C09	版本	第 2.1 版	頁碼/總頁數	2/7

（三）合併症

- 1.術後傷口出血。
- 2.皮下氣腫。
- 3.傷口感染。
- 4.氣切套管阻塞。
- 5.氣管瘻管形成。
- 6.氣切造口周圍肉芽組織及狹窄。

（四）護理問題

- 1.呼吸道清除功能不良/與痰液黏稠及咳嗽技巧不正確有關。
- 2.易感染/與皮膚完整性受損有關。
- 3.焦慮感受/與手術有關。
- 4.身體心像不一致/與手術至顏面外觀改變有關。

（五）護理措施

- 1.呼吸道清除功能不良/與痰液黏稠及咳嗽技巧不正確有關
 - (1) 評估呼吸狀況，記錄呼吸頻率和節律、呼吸音、咳嗽和分泌物的特性。
 - (2) 監測脈搏血氧定量法和動脈血液氣體分析值。
 - (3) 協助病人採高坐臥姿；鼓勵改變姿勢，至少每 2 小時翻身一次以移動分泌物。
 - (4) 會客時可與家屬一起協助病人進行上肢上舉姿勢，再漸進式結合彈力帶的方式進行肢體復健，以增加肢體肌肉力量。
 - (5) 教導病人深呼吸後有效咳嗽。
 - (6) 教導病人咳嗽時運用外力輔助性技巧，藉由手或枕頭向身體方向內推以增加腹肌縮收力量。
 - (7) 必要時，抽吸呼吸道，抽吸時間成人不超過 15 秒，小孩為 5-10 秒。
 - (8) 抽吸前後，先給予 100%氧氣或鼓勵深呼吸，使肺過度充氣。
 - (9) 依醫囑執行胸部物理治療，例如叩擊、姿位引流。

主題名稱	氣切傷口照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C09	版本	第 2.1 版	頁碼/總頁數	3/7

(10) 提供病人足夠氧合狀態：鼓勵經口攝取液體或依醫囑維持靜脈輸液。

(11) 依醫囑給予噴霧治療或濕潤的氧氣，可稀釋痰液。

(12) 記錄護理措施的效果。

2. 易感染/與皮膚完整性受損有關

(1) 每班評估傷口大小及分泌物情形。

(2) 定期檢視皮膚易受壓處，固定氣管切開造口的繃帶因環繞病人頸部的皮膚，易導致壓迫頸部組織，造成血液供給減少及組織潰瘍。

(3) 使用適當的敷料及清潔液，減少傷口的刺激，並預防皮膚潮濕。

(4) 治療前後確實洗手。

(5) 避免磨擦破損及微生物的孳生皮膚破損部位的護理可使用透明敷料，如 OP-Site 等。

(6) 亦可利用泡沫環和親水敷料來降低氣管切開傷口產生的壓力性損傷。

3. 焦慮感受/與手術有關

(1) 以簡單易懂的方式提供術後護理指導，澄清疑惑，加強對術後管路的認知。

(2) 與病人建立良好的治療性人際關係，運用傾聽技巧確認焦慮情緒。

(3) 教導肌肉放鬆方法、音樂療法等行為治療。

(4) 提供親情支援系統，以達到情緒宣洩，心理支持的效果。

4. 身體心像不一致/與手術至顏面外觀改變有關

(1) 評估病人對傷口的適應程度，可利用鏡子讓病人能觀察護理人員操作護理的步驟，循序漸進面對傷口外觀的改變。

(2) 提供隱私的環境，適當協助、傾聽並澄清病人所感覺到的，發展其實際的身體心像。

(3) 適切支持並肯定病人其他方面的能力與價值。

(4) 在不影響呼吸情況下可鼓勵病人穿高領衣服來覆蓋氣切傷口。

(5) 鼓勵病人及家屬參與傷口照護，有助於身體心像之恢復與適應。

主題名稱	氣切傷口照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C09	版本	第 2.1 版	頁碼/總頁數	4/7

（六）衛教指導

1. 氣切傷口護理

換藥前需洗手而氣管切開造口的傷口於 24 小時後需每 8 小時消毒一次，若有滲液或痰液汙染時須隨時消毒傷口及更換紗布，換藥過程須採無菌技術執行，病人採半坐臥式，先除去汙染的氣切紗布，造口周圍以生理食鹽水清洗及 A-q B-Iodine 消毒，更換乾淨的氣切紗布，觀察並記錄傷口有無感染之徵象，進行護理措施同時觀察有無合併症發生。

理想的固定方法必須提供最少的管路接觸面以及最好的舒適度，每天或固定裝置汙穢、鬆脫時，需重新更換固定裝置，此外，需隨時注意固定帶下方皮膚的完整性，評估受壓部位。

（七）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

（略）

五、流程圖

（略）

六、參考資料

- （一）李和惠等人(2023)．內外科護理學（下冊）（七版）．華杏。
- （二）洪藝如、徐淑芬、馬嘉慧(2023)．運用共享決策協助慢性阻塞性肺病病人執行氣切之護理經驗．領導護理，24(1)，96-110。
- （三）高美玲、蔡伶珍、劉品筠、楊淑宜（2020）．【論文摘要】運用居家肺部復原策略改善氣切留置患者呼吸及生活品質的照護經驗．呼吸治療，19，53-54。

主題名稱	氣切傷口照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C09	版本	第 2.1 版	頁碼/總頁數	5/7

https://doi.org/10.6269/JRT.202010/SP_19.0031

- (四) Carroll, D. J., Leto, C. J., Yang, Z. M., Fritz, M. A., Ho, B., Byrd, J. K., ... & Postma, G. N. (2020). Implementation of an interdisciplinary tracheostomy care protocol to decrease rates of tracheostomy-related pressure ulcers and injuries. *American journal of otolaryngology*, 41(4), 102480.
- (五) Moser, C. H., Peeler, A., Long, R., Schoneboom, B., Budhathoki, C., Pelosi, P. P., Brenner, M. J., & Pandian, V. (2022). Prevention of Tracheostomy-Related Pressure Injury: A Systematic Review and Meta-analysis. *American journal of critical care : an official publication, American Association of Critical-Care Nurses*, 31(6), 499–507.
- <https://doi.org/10.4037/ajcc2022659>
- (六) Kennedy, M. M., Abdel-Aty, Y., & Lott, D. G. (2021). Comparing tracheostomy techniques: Bjork flap vs. tracheal window. *American Journal of Otolaryngology*, 42(6), 103030.

七、附件

(略)

主題名稱	氣切傷口照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C09	版本	第 2.1 版	頁碼/總頁數	6/7

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
102.11.27	1.0	新制定	102 年 11 月 27 日護理部照護標準委員會通過；102 年 11 月 27 日公布
103.06.30	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
103.08.31	1.1	說明內容部份修辭潤飾	103 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
104.08.31	1.2	1.第三項說明內容部份刪修 2.更新第六項參考資料	104 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
105.08.31	1.3	1.第三項第(一)目部分說明內容更新。 2.新增參考文獻出處於內文中。	105 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
106.08.31	1.4	1. 第三項第(一)目部份內容刪修。 2. 新增參考文獻出處於內文中。 3. 修正 APA 格式。	106 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
107.06.29	1.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.09.12	1.5	第二項新增（含中興分院）。	107 年 09 月 12 日護理長會議通過
108.09.23	1.6	1. 第三項第四、五目新增說明文字：與...有關。 2. 第三項第七日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 09 月 11 日護理長會議通過；108 年 09 月 23 日督導會議通過公布。
109.08.06	1.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.09.07	1.7	內文更新文獻年限且修正 APA 格式	110 年 08 月 05 日照護標準組會議通過；110 年 08 月 11 日護理長會議通過；110 年 09 月 07 日督導會議通過公布。

主題名稱	氣切傷口照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C09	版本	第 2.1 版	頁碼/總頁數	7/7

修正日期	版本	修正說明	備註
111.09.06	1.8	1. 更新第三項第四、五目護理問題。 2. 內文參考文獻引用刪除。	111 年 08 月 04 日照護標準組會議通過； 111 年 08 月 10 日護理長會議通過；111 年 09 月 06 日督導會議通過公布。
112.09.05	1.9	1. 第三項第一目說明內容修訂。 2. 第三項第四目之 1、第五目之 1.護理問題及護理措施相關內容修訂。 3. 第三項第六目說明內容修訂 4. 更新第六項參考資料。	112 年 08 月 03 日照護標準組會議通過； 112 年 08 月 09 日護理長會議通過；112 年 09 月 05 日督導會議通過公布。
113.09.03	2.0	更新第六項參考資料。	113 年 08 月 08 日照護標準組會議通過； 113 年 08 月 14 日護理長會議通過；113 年 09 月 03 日督導會議通過公布。
114.10.08	2.1	1.第三項第(五)目之 2 新增(6)。 2.更新第六項參考資料。	114 年 08 月 07 日照護標準組會議通過； 114 年 09 月 10 日護理長會議通過；114 年 10 月 08 日督導會議通過公布。